

ANAMNÈSE

THEORIE :

L'anamnèse représente l'histoire médicale du patient. Les informations sont apportées par le patient et sont censées permettre la construction d'hypothèses diagnostiques.

Motif de consultation

Anamnèse actuelle

Anamnèse par système

Antécédents personnels

Anamnèse personnelle

Antécédents familiaux

Anamnèse psycho-sociale

Les traitements

Conclusion



Maladies et accidents
actuels du patient

Facteurs de risques

Mieux connaître et comprendre le patient

PRATIQUE :

1. Motif de consultation : souffrance/plainte ou bilan de santé
2. Anamnèse actuelle :
 - 1^{ère} question ouverte : *Qu'est-ce qui vous amène/ne va pas ? Pouvez-vous m'en dire plus ?*
 - 2^{ème} question précision/confirmation : *Qu'entendez vous par ... ?*
Caractériser le symptôme : *horaire, intensité, qualité, mode, associés, déclenchant, reposant, synthèse*
3. Anamnèse par système
 - a. Générale
 - i. Etat général
 - ii. Poids (gain, perte, cinétique)
 - iii. Température (orale : 35.5-37.5, Tmax : 37.2 le matin et 37.8 le soir)
 - iv. Adénopathies (ganglion gonflé)
 - v. Sudations (nocturnes)
 - vi. Allergies
 - b. Cardiovasculaire
 - i. Douleurs thoraciques (positio-dépendante)
 - ii. Palpitations
 - iii. Dyspnée
 - iv. Orthopnée
 - v. Dyspnée paroxystique nocturne
 - vi. Pollakiurie
 - vii. Oedèmes des membres inférieurs
 - viii. Cyanose périphérique
 - ix. Varices
 - x. Ulcères
 - xi. Syncopes
 - c. Pulmonaire
 - i. Douleurs thoraciques (respiro-dépendante, positio-dépendante)
 - ii. Dyspnée (stades 1 à 4)
 - iii. Toux (sèche/productive)

- iv. Expectorations (volume, sang)
- v. Asthme (facteurs déclenchants)
- vi. Ronflements
- d. Digestive
 - i. Dysphagie (liquides, solides)
 - ii. Nausées, vomissements (biliaires/non-biliaires)
 - iii. Pyrosis (brûlures intestinales, acidité, aigreur)
 - iv. Réplétion gastrique
 - v. Douleurs abdominales
 - vi. Selles : fréquence, qualité, incontinence, sang (noir (méléna) VS rouge)
 - vii. Ictère (peau jaune => pigment biliaires dans le sang)
- e. Génito-urinaire
 - i. Urines : fréquence, quantité, couleur, odeur
 - ii. Dysurie : douleurs, brûlures
 - iii. Douleurs loges rénales
 - iv. Fonction sexuelle, libido, douleurs
 - v. Menstruations : ménarches, ménopause, cycles, aménorrhée
 - vi. Pertes vaginales, ulcérations
- f. Neurologique
 - i. Céphalées
 - ii. Vertiges
 - iii. Acuité visuelle
 - iv. Acuité auditive
 - v. Troubles moteurs, sensitifs
 - vi. Troubles de l'équilibre
- g. Ostéo-articulaire
 - i. Douleurs articulaires (inflammatoire VS mécanique)
 - ii. Œdème, rougeur
 - iii. Limitation fonctionnelle d'un membre
 - iv. Perte de taille (> 4cm)
- h. Dermatologique
 - i. Eruption cutanée (exanthème, érythème, ...)
 - ii. Dyscoloration cutanée
 - iii. Lésions cutanées
 - iv. Ongles
 - v. Pilosité
- i. Psychiatrique
 - i. Structure tout en permettant la discussion
 - ii. Anamnèse standard : actuelle, personnelle, ATCD psy et somatique
 - iii. Status
 - 1. Apparence : tenue, hygiène, vigilance, calme, collaborant
 - 2. Cognitif : orienté (quand, où, qui), partage le focus et la conversation, troubles mnésiques
 - 3. Discours : cohérent, cours de la pensée, contenu de la pensée
 - 4. Humeur : dépressif, anxiété, manie
 - 5. Trouble psychotique
 - 6. Idées suicidaires
- 4. Antécédents personnels
 - a. Maladies et traitements (chronologie)
 - b. Accidents et blessures
 - c. Opérations
 - d. Hospitalisations

5. Anamnèse personnelle
 - a. Etat général ressenti par le patient
 - b. Vaccins
 - c. Risques liés à l'environnement
 - d. Exercice et loisirs
 - e. Habitudes alimentaires
 - f. Alcool (dépendance physique dès 1bt/jour), tabac (en UPA = (paq/j)*années), substances
6. Antécédents familiaux
 - a. Pathologies retrouvées dans la famille
 - b. Pathologies (et causes de décès) des parents et grands-parents
 - c. Pathologies chez les frères et sœurs
 - d. Pathologies chez les enfants
7. Anamnèse psycho-sociale
 - a. La situation à domicile
 - b. La vie au quotidien
 - c. Les expériences importantes
 - d. Les croyances religieuses
 - e. Les opinions du patient
8. Les traitements
 - a. Le traitement régulier
 - b. Les traitements occasionnels
 - c. Les « substances annexes » (vitamines, plantes)
9. Conclusion
 - a. Reprendre les points importants
 - b. Montrer que l'on a compris la plainte, les attentes
 - c. Proposer une transmission de l'information et une prochaine séance très prochainement

STATUS

STATUS COMPLET

THEORIE :

Cette méthode, utilisée principalement par la PMU, les généralistes et les internistes, permet d'effectuer en 20 minutes un status complet en suivant la systématique « tête aux pieds » et « debout-assis-couché ». Ainsi l'examen suit une certaine logique et le patient n'est pas manipulé dans tous les sens.

PRATIQUE :

GENERAL

Examen général – debout

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Poids | 4. Epreuve du tabouret |
| 2. Taille | 5. Mingazzini |
| 3. Romberg (équilibre) | 6. Marche |

Examen général - assis

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Température | 3. Fréquence cardiaque |
| 2. Tension artérielle assise | 4. Fréquence respiratoire |

Examen dermatologique

Il s'effectue tout au long de l'examen clinique. Toute la peau doit être visualisée et plus particulièrement :

1. Observation de la peau, cheveux, ongles
2. Recherche de signes cutanés de troubles vasculaires
3. Recherche de néoplasie ABCDE (Asymétrie, Bordure, Couleur, Diamètre, Élévation)

TETE ET COU

Examen ORL – assis

1. Examen des oreilles : pavillon et otoscopie, estimation de l'audition par la voix chuchotée et le masquage contralatéral en appuyant sur le tragus
2. Examen de la bouche, dents, sillons, langue, muqueuse
3. Examen du fond de gorge, voile du palais, luette et amygdales
4. Examen du nez

Examen ophtalmique – assis

1. Observation des sclères et des conjonctives
2. Réflexe pupillaire (en même temps que ORL, avec lumière otoscope)

Examen neurologique des nerfs crâniens

Autres

1. Palpation des aires ganglionnaires (cervicale ant et post, sous mandibulaire, claviculaire et axillaire)

2. Palpation de la thyroïde : placé derrière le patient, on place la pulpe des doigts de chaque côté du cartilage cricoïde. Le patient avale ou boit de l'eau et on doit sentir l'isthme de la thyroïde. Il faut noter la taille, forme et consistance ainsi que la présence d'un nodule ou de douleurs.

THORAX ET MEMBRES SUPERIEURS

Examen pulmonaire – assis

1. Observation thorax et respiration
2. Percussion des plages pulmonaires
3. Auscultation pulmonaire antérieure et postérieure

Examen musculo-squelettique - assis

1. Observation et percussion du rachis
2. Observation des articulations
3. Examen des articulations des épaules, coudes et poignets
4. Evaluation de la trophicité musculaire

Examen vasculaire - assis

1. Palpation des artères radiales
2. Evaluation de la température des mains et du temps de recoloration

Examen neurologique des membres supérieurs – assis

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Examen de la motricité | 4. Epreuve doigt-nez |
| 2. Examen de la sensibilité | 5. Diadococinésie (marionnette) |
| 3. Epreuve des bras tendus | |

(Examen des seins)

Examen cardio-vasculaire – couché

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Observation | 4. Auscultation des troncs artériels (carotides) |
| 2. Palpation du choc de pointe | |
| 3. Auscultation cardiaque | |

ABDOMEN

Examen de l'abdomen – couché

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Observation | 6. Palpation de la rate |
| 2. Auscultation | 7. Palpation et percussion du foie |
| 3. Palpation superficielle | 8. Palpation et percussion des reins |
| 4. Palpation profonde | 9. Toucher rectal |
| 5. Mc Burney et Murphy | |

Examen vasculaire – couché

1. Auscultation des troncs artériels à la recherche d'un souffle : aorte abdominale et rénale

MEMBRES INFÉRIEURS

Examen musculo-squelettique – couché

1. Observation des articulations
2. Examen des articulations des hanches, genoux et chevilles
3. Evaluation de la trophicité musculaire

Examen vasculaire – couché

1. Palpation des artères fémorales, tibiales postérieures et pédieuse)
2. Evaluation de la température des pieds et de la recoloration
3. Examen du système veineux (OMI, varices, dermite ocre, botte scléreuse, corona phloebectica)

Examen neurologique des membres inférieurs

1. Examen de la motricité/force
2. Examen de la sensibilité
3. Examen des réflexes ostéo-tendineux

Autres

1. Palpation des aires ganglionnaires fémorales

STATUS CARDIAQUE**THEORIE :**

Il existe 4 foyers de mesure représentant chacun une valve : valve aortique (2^{ème} intercostale dt.), valve pulmonaire (2^{ème} intercostale g.), valve tricuspide (4^{ème} intercostale) et valve mitrale (5^{ème} intercostale, médio-claviculaire)

Le bruit cardiaque se divise en deux : toum et tac. Le premier son B1 plus long et plus grave représente le début de la systole et la fermeture des valves atrio-ventriculaire. Il est mieux perçu à la pointe et est synchrone avec le pouls.

B2 représente le début de la diastole et la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Il est plus court et plus sec (tac). Lors de l'inspiration profonde, B2 se dédouble en deux bruits A2 et P2 qui représentent les valves aortiques et pulmonaires. Elles se mesurent respectivement à l'apex et à la base.

PRATIQUE :*Inspection*

1. Désinfection des mains
2. A droite du patient torse-nu
3. Symétrie du thorax, cicatrice, aspect de la peau, pulsation visible

Palpation

4. FC et FR
5. Pouls carotidien droite et gauche en parallèle de l'écoute (synchrone avec B₂)
6. Choc de pointe/apexien sur la 5^{ème} intercostale médio-claviculaire. Plus prononcé en position latérale.

Auscultation

7. Ecoute au diaphragme des 4 foyers en faisant un trajet en Z (2.2.4.5). Différencier B1 et B2
8. Ecoute à la cloche de la mitrale et la tricuspide
9. Différencier A2 et P2 en écoutant sur le foyer pulmonaire, en demandant au patient d'inspirer profondément

STATUS PULMONAIRE**THEORIE :**

En principe le poumon doit avoir une sonorité spécifique. Le cas inverse, il peut avoir un emphysème (sonorité tympanique/creuse comme l'intestin) ou un surplus de mucus (sonorité mate/pleine comme le foie).

PRATIQUE :

1. Désinfection des mains
2. Patient couché sur le dos

Inspection

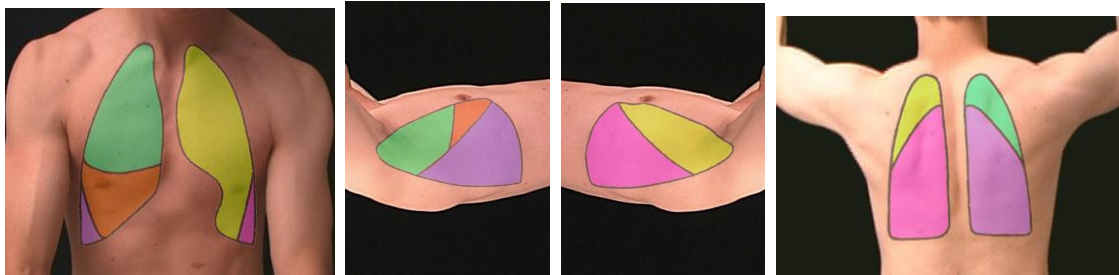
3. Détresse respiratoire : cyanose, bruits, efforts musculaires (sterno-cléido)
4. Formes du thorax : asymétrie, déformation, creux
5. Mouvements respiratoires : symétrie, expansion thoraco-abdominale, abdomen surtout
6. Fréquence respiratoire sur 30 s, N = 10-20 par minute

Palpation

7. Ganglions mandibulaires, cervicales, sus-claviculaires et axillaires par "pianotage" des doigts
8. Anomalies visibles et zones douloureuses. Approche progressive.
9. Apposition des mains sur l'abdomen, pouce au centre et au-dessus (sous 10^{ème} côte) afin de vérifier la symétrie d'ampliation

Percussion

10. Tapotement avec le majeur droite sur l'articulation distale du majeur gauche bien appuyé sur le thorax du patient. Son normalement intermédiaire : ni tympanique, ni mate.
11. Tapoter en symétrie en descendant. *Attention* à la matité du cœur. S'arrêter à la matité du foie à droite et le tympanisme de l'intestin à gauche.

*Auscultation*

12. Écouter avec le stéthoscope en symétrie. Son homogène et régulier comme le bruit de la mer. Les Textbook mentionnent une auscultation de haut en bas mais la pratique veut qu'un petit vieux dyspnéique ne saura souffler que 3 fois correctement et il est donc conseiller de démarrer aux bases pour ne pas y manquer les principaux signes pulmonaires.
13. Recommencer pour le dos avec le patient dans la position assis.

STATUS DIGESTIF

THEORIE :

Connaître les 9 régions de l'abdomen :

Hypochondre droit	Epigastre	Hypochondre gauche
Flanc droit	Région ombilicale	Flanc gauche
Fosse iliaque droite	Hypogastre	Fosse iliaque gauche

PRATIQUE :

Position du patient :

1. couché avec les 9 cadrans déshabillés, détendu, jambe légèrement pliée et bien éclairé

Observation:

2. le *visage* : malaise, douleur
3. la *peau* : cicatrices, vergetures (sorte de cicatrice par déchirure), veines dilatées, lésions cutanées, autres ...
4. *allure* de l'abdomen : symétrie, plat, arrondi, protubérance
5. *mouvements* : respiratoires, péristaltiques, pulsatiles

Auscultation : bruits anormaux, souffles vasculaires,

6. Etudier la *motilité* intestinale
7. *Sténose* rénale éventuelle (sur point rouge)
8. *Occlusions* vasculaires

Percussion : le long de la ligne médio-axillaire

9. Droite : matité : foie > tympanique : organes digestifs
10. Gauche : tympanisme : poche d'air gastrique

Palpation : demander au patient d'indiquer les zones douloureuses

11. Avec la pulpe des doigts, une main posée, l'autre qui appuie dessus : recherche de masses, dureté
12. Test de détente : relâche soudainement la pression apposée

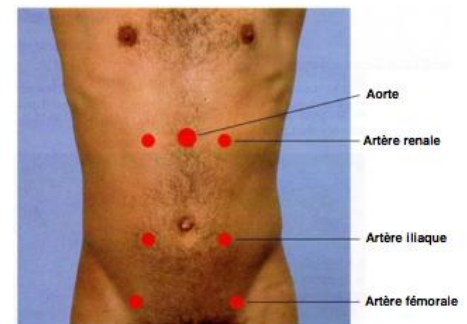
Examen par organes

13. Foie : main gauche dans le dos, sous le foie, parallèlement aux deux dernières côtes / main droite appuie vers le foie avec la pulpe des doigts / Demander au patient de respirer profondément (signe de Murphy positif à la cholécystite)

14. Rate : percussion latéralement et en allant de plus en plus dorsalement / Palpation main gauche: dessus et autour du patient pour soulever et pousser vers l'avant la base thoracique gauche / main droite: sous le rebord costal gauche, appuie en direction de la rate / Demander au patient d'inspirer profondément

Signes

15. Point de Mc Burney, Blumberg, Rovsign, Signe du psoas, Grey-Turner et Cullen (péri-ombilical)



STATUS NEUROLOGIQUES

NERFS CRANIENS

THEORIE :

Un examen des nerfs crâniens bien maîtrisé peut être effectué rapidement et permet d'exclure des atteintes de l'un des 12 nerfs ou des atteintes centrales, dans des situations de névrites, polyneuropathies, AVC, etc.

PRATIQUE :

Le plus simple est de tester nerfs après nerfs dans l'ordre :

- I. *Nerf olfactif* : utiliser une fiole avec substance odorante et faire sentir alternativement droite et gauche en obstruant correctement la narine controlatérale avec l'index
- II. *Nerf optique* : tester les 4 quadrants du champ visuel. Le patient regarde le nez du soignant et mentionne quels doigts s'agitent dans ces quadrants. Concerne l'élévation de l'œil et de la paupière, l'abaissement et l'adduction.
- III. *Nerf oculomoteur* : Vérifier l'oculomotricité par la méthode du H/N. Le patient garde la tête droite et suit avec ses yeux le doigt du soignant qui forme un N ou un H.
La constriction pupillaire (afférence parasympathique) a une branche qui passe par le III.
- IV. *Nerf trochléaire* : idem que III, concerne la rotation interne, abduction et abaissement.
- V. *Nerf trijumeau* : tester la sensibilité dans les zones faciales innervées par V1, V2 et V3 (en descendant). Comparer droite et gauche. Palper contraction du m. temporal et m. masséter à la mastication.
- VI. *Nerf abducens* : idem que III, concerne l'abduction des yeux.
- VII. *Nerf facial* : Faire froncer les sourcils, gonfler les joues, fermer les yeux, lever les yeux, montrer les dents. Comparer la symétrie. Aussi le réflexe cornéen.
Goût des deux tiers antérieurs de la langue
- VIII. *Nerf vestibulo-cochléaire* : Tester l'ouïe en frottant les doigts à proximité de l'oreille. Le patient indique de quels côtés est le bruit
- IX. *Nerf glosso-pharyngien* : symétrie de la luette et réflexe de déglutition
- X. *Nerf vague* : motricité et sensibilité du pharynx et larynx
- XI. *Nerf accessoire* : vérifier l'élévation des épaules (m. trapèze) et la rotation de la tête (m. SCM)
- XII. *Nerf hypoglosse* : motricité de la langue : le patient tire la langue et la mobilise dans les 4 axes.

REFLEXES

Les ROT sont déclenchés par exercices, en couple.

THÉORIE :

- rappel cotation 0 - 4+ (normal 2+ ; si >2+ = séméiologie pyramidale ; si <2+ = séméiologie périphérique).
- Niveaux métamériques des ROT limités : C6 et C7 au MS ; L4 et S1 au Mi
- marteau à tête lourde.
- évoquer 2-3 fois à 1 niveau, puis déclencher le même ROT controlatéral.

PRATIQUE :

1. assis (biceps brachial C5-6; brachioradial C6 ; triceps brachial C7; quadriceps L4 ; Achilléen S1).
2. couché (biceps brachial ; brachioradial ; triceps brachial ; quadriceps ; Achilléen ; cutané abdominal ; cutané plantaire = Babinski si extension anormale) : Tous les ROT sont évocables du même côté du lit sauf 1 Achilléen controlatéral.
3. Eventuellement manœuvre de facilitation (Jendrassik) : contracte la mâchoire ou traction entre les deux bras.

Erreurs fréquentes: le marteau n'atteint pas la cible du tendon; il n'est pas déclenché assez fort; les ROT ne sont pas évoqués du même côté du lit ; le réflexe cutané plantaire n'est pas frotté suffisamment au bord latéral du pied.

FORCE

La force musculaire, puis les épreuves fonctionnelles, sont appréciées par exercices, en couple.

THÉORIE :

- Rappel cotation force musculaire ; système MRC 0 - 5 (normal = 5, contre gravité avec maintien = 3), si < 5 = parésie ou faiblesse musculaire (MRC=Medical Research Council ou conseil scientifique britannique ayant reconnu après la 1^{ère} Guerre mondiale l'utilité d'une cotation internationale).
- La précision de l'examen est fonction des hypothèses de travail.
- Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits.

PRATIQUE :

1. Assis, en symétrie pour les MS proximaux (sous-épineux; deltoïde ; biceps brachial ; triceps brachial ; extenseurs poignet ; fléchisseurs poignets ; extenseurs doigts ; fléchisseurs doigts ; interosseux et abd doigt V ; court abducteur du pouce ; fléchisseurs cuisse ; quadriceps ; fléchisseurs genoux).
2. Motilité fine des doigts et des orteils (reconnaissance de l'atteinte pyramidale).
3. Couché (extenseurs pied et orteils ; fléchisseurs orteils), mais les muscles examinés en position assise peuvent aussi être examinés en position couchée.
4. Épreuves fonctionnelles : Relever de la tête et du tronc ; **épreuve des bras tendus** et jambes fléchies ; élève les **bras en dessus de la tête** ; accroupissement et relever possible (si pathologique = signe de Gowers) ou **épreuve du tabouret** ; **marche sur les pieds et les talons** ; tient sur une jambe (si parésie du moyen fessier = signe de Trendelenbourg).

SENSIBILITÉ

Les différentes sensibilités, puis les épreuves fonctionnelles, sont appréciées par exercices, en couple.

THÉORIE :

- Rappel des différentes modalités protopathiques et épicritiques.
- Connaître les niveaux mamelons, ombilic, racines des extrémités.
- La précision de l'examen est fonction du contexte.
- Les épreuves fonctionnelles permettent de donner une appréciation de sévérité des déficits.

PRATIQUE :

Examen systématique à la base unguéale des index et des gros orteils (si pas de reconnaissance, remonter proximale ; poignet/cheville ; coude/genoux).

1. Reconnaissance au piquer toucher par un coton tige cassé en 2.
2. Reconnaissance du sens position ou de arthocinétique.
3. Reconnaissance du sens de la pallesthésie (vibration).

Nota bene : Le sens de température nécessite l'utilisation de petits Erlenmeyer remplis d'eau chaude/froide. L'étude du sens de la stéréognosie (objet fin dans la main sans contrôle visuel) peut être utile dans une appréciation intégrée des sensibilités (cortex pariétal).

4. Épreuves fonctionnelles : démarche du funambule (pieds appondus l'un devant l'autre) ; épreuve de Romberg, d'abord pied serrés et bras tendus, puis fermeture oculaire ; aussi épreuve des bras tendus et jambes fléchies.

Erreurs fréquentes: les stimulations toucher/piquer sont légères et répétées au même site 2-3 fois ; les sites d'examen sont fonction des hypothèses de travail : déséquilibre à la marche (ci-dessus), dans un territoire d'innervation d'un tronc nerveux ou d'une main ; dans les troubles sphinctériens, ne pas oublier de rechercher des déficits au niveau de la queue de cheval (faces postérieures des cuisses et des jambes, fesses et périnée).

STATUS ARTICULAIRE**THEORIE**

Le status articulaire mesure la performance des articulations en degré ou tout simplement en résistance à une force imposée. On parle d'actif et de passif :

Actif : le patient va au maximum et on mesure

Passif : le patient se laisse faire par le soignant (valeur passif > actif)



VARUS



VALGUS

PRATIQUE*Epaule*

1. Flexion: main en supination.
Goniomètre sur scapula et membre
2. Extension : idem. Avec coude plié = pas d'ambiguïté
3. Abduction : jusqu'à bascule de la scapula
4. Adduction : bras dans le dos, pas mesuré
5. Rotation ext. : bras le long du corps, coude plié, main en supination

6. Rotation int. : main sur le ventre, pouce sur xyphoïde, force mise par le soignant : le patient doit essayer de rapprocher la main de son ventre (belly press) OU main dans le dos : le patient doit essayer d'éloigner sa main de son dos (lift oft)

Genou

1. Flexion : mesure de l'angle
2. Repos : en principe 0° sauf si pathologique
3. Extension : mesure de l'angle (quelques degrés)

Laxité

1. Cheville dans les mains : on les colle ensemble, condyles doivent toucher aussi. Eventuel varus ou valgus.
2. Jambe étendue dans les mains, patient relâche ses muscles. On teste laxité interne et externe : normalement nul avec jambe étendue
3. Jambe pliée légèrement (10-30°). Même test : normalement légère laxité (externe > interne)

GALS

THEORIE :

Le GALS est un examen qui permet le dépistage rapide des atteintes orthopédiques et rhumatismales principales. C'est un bon moyen d'effectuer un status orthopédique pour un check-up typiquement.

C'est aussi surtout un examen qui s'effectue en 15 minutes et qui revient volontiers à l'ECOS de 3^{ème} année. La partie ci-dessous est directement reprise de la grille ECOS.

PRATIQUE :

Debout

1. Observer la marche du patient
2. Observer la statique rachidienne dans le plan frontal postérieur
3. Observer le patient depuis l'arrière à la recherche d'un kyste poplité et d'anomalies d'axes de l'arrière des pieds
4. Observer la statique rachidienne dans l'axe sagittal et demander aux patients de se pencher les genoux et d'essayer de toucher ses pieds sans plier les genoux
5. Observer les inclinaisons latérales de la nuque
6. Demander au patient de mettre les mains derrière la tête et de mettre les coudes en arrière
7. Demander au patient de tendre les mains, paumes vers le haut et observer l'aspect des mains
8. Demander au patient de tourner les mains pour évaluer la pro-supination et observer la face dorsale des mains
9. Demander au patient de serrer les poings et effectuer une manœuvre d'étreinte au niveau des deux mains (Gänslen ?)

Couché

10. Examiner les membres inférieurs à la recherche d'un défaut d'axe, d'amyotrophie ou d'autres anomalies
11. Tester la mobilité en flexion/extension des deux genoux
12. Examiner les rotations internes et externes des deux hanches
13. Examiner la voûte plantaire des deux pieds pour une anomalie et effectuer une manœuvre d'étreinte au niveau des têtes métatarsiennes
14. Effectuer ce status dans l'ordre de manière systématique

STATUS ORL

PRATIQUE :

1. *Ganglions* : Palpation des aires ganglionnaires cervicales antérieures et postérieures ainsi que des mandibulaires, claviculaires et axillaires.
2. *Bouche* : examen des sillons gingivaux externes et internes ainsi que de la langue et la muqueuse avec l'abaisse-langue
3. *Fond de bouche* : examen du fond de gorge, amygdales, luette et oropharynx avec l'abaisse-langue
4. *Larynx* : chauffer le miroir, tenir la langue avec une compresse entre les doigts III et IV et examiner l'épiglotte ainsi que les cordes vocales de manière statique et dynamique
5. *Nasopharynx* : observer le nasopharynx avec le miroir de Saint-Michel inclinable
6. *Nez* : observation du cornet moyen et de la cavité nasale avec le spéculum nasal
7. *Oreille externe* : examen du pavillon et de la partie rétro-auriculaire.
8. *Oreille moyenne* : observation du conduit auditif et du tympan, épreuve de Valsalva (expire en se bouchant le nez) et de Toynbee (déglutit en se bouchant le nez). Eventuellement Siègle (hermétique avec air insufflé) si matériel disponible.

STATUS OPHTALMIQUE

THEORIE :

Le status proposé ci-dessous est celui utilisé à l'hôpital ophtalmique. Pour effectuer un examen rapide des yeux, référez-vous à la section *Skills Vision*

Status complet :

1. *L'œil et ses annexes* : Conjonctive bulbaire et palpébral (éversion de la paupière)
Glande lacrymale (lever paupière et faire regarder en inféro-interne)
2. *Champ visuel* : Œil caché, cadran par cadran : champ (mouvement) et acuité (nb doigt)
3. *Oculomotricité* :
 Fixation : Le patient fixe le nez du soignant, sans mouvement
 Poursuite : Suivre un mouvement harmonieux du doigt
 Fins de courses latérales et verticales
 Saccade : Patient regarde nez puis doigt qui change de place
 Convergence : Patient fixe le doigt du soignant qui se rapproche en faisant des petits mouvements. Observer le myosis
 Oculomotricité : horizontal, vertical et diagonal
4. *Pupilles* : Isocore, isoréactive et convergence en myosis
5. *Acuité visuelle* : Monoculaire et avec les lunettes ! De près et de loin, avec les tableaux.
6. *Vision des couleurs* : Avec le carnet des couleurs (test de Ishihara) en monoculaire
7. *Fond d'œil* : Observation directe sans dilatation de l'œil droite avec l'œil droite et l'œil gauche avec l'œil gauche.

SKILLS

DESINFECTION DES MAINS

Savon anti-septique (Baktolin)

Le lavage complet des mains au savon est irritant et se fait au début et à la fin du service, avant et après la pause de midi et les toilettes et quand les mains sont sales. Le savon n'est pas à utiliser à chaque fois car c'est une procédure longue et irritante pour les mains.

Solution hydro-alcoolique

La solution hydro-alcoolique s'utilise dans 5 situations :

1. Avant patient
2. Après patient
3. Avant acte septique
4. Avant et après contact avec liquide biologique/gants
5. Avant et après contact objets ou environnement du patient

COMMUNICATION – ECOS

A chaque poste ECOS, cinq points (soit ¼ selon les postes) sont consacrés à la communication selon les points suivants. Ceux-ci ont été directement repris depuis une grille d'évaluation d'ECOS.

1. S'est présenté : a donné son nom **et** a appelé le patient par son nom
2. A dit qu'il est étudiant en médecine **et** demande l'accord du patient pour mener l'examen
3. Est attentif au confort et au bien-être du patient (l'installe, s'inquiète de son bien-être, etc)
4. Maintient un contact visuel avec le patient
5. Termine l'examen physique de manière adéquate (salue le patient, etc)

SKILLS TENSION ARTÉRIELLE ET POULS

THEORIE :

La systole est le moment d'éjection du sang dans la circulation : la pression est maximum. La diastole à l'inverse a la pression minimum et représente le moment de remplissage du ventricule et de fermeture des valves atrio-ventriculaires.

PRATIQUE TA :

1. Désinfection des mains
2. Manomètre face à nous, sans fuite d'air et avec la graduation à zéro
3. Patient calme, décontracté, silencieux, assis et bras libre.
4. Face à la colonne, repérer la zone de battement max de l'artère humérale (FC humérale)
5. Poser le brassard à 2-3 cm au dessus du pli du coude
6. Gonfler le brassard pour une première estimation (pression systolique)
7. Nouveau gonflage 30 mmHg au dessus de la pression systolique
8. Dégonfler à 2 mmHg/s en mesurant la systole et la diastole
9. Mesure de la FC

PRATIQUE POULS :

1. Désinfection des mains
2. Prendre chaque fois les pouls 15 sec. de chaque côté. Prendre 60 sec. si irrégulier.
3. Pouls carotidien (pas trop longtemps, un côté à la fois, ne pas massé)
4. Pouls radial
5. Pouls huméral (sous le biceps, partie distale, interne)
6. Pouls tibial (derrière la malléole **int**)
7. Pouls pédieux (entre 1^{er} et 2^{ème} métatarsien, parfois absent)

SKILLS VISION**STATUS RAPIDE :**

1. On demande au patient de fixer notre nez
2. On approche sa main de son champ visuel : le patient mentionne dès qu'il l'aperçoit (détection d'hémianopsie, etc)
3. Test de la différenciation des couleurs (test de Ishihara : cahier de chiffres en couleurs)
4. Test d'acuité avec lettres à distance
5. Test de convergence (accommodation) : on montre un objet de loin, puis de près.

SKILLS AUDITION**THEORIE :**

L'amplification créée par le conduit auditif externe, le tympan et les osselets induisent que l'on entend mieux un son externe qu'en vibration direct sur notre corps.

PRATIQUE :

1. Désinfection des mains
2. Observation du *conduit auditif* (ex. oreille droite)
 - a. Se tenir à droite du patient
 - b. Lui faire pencher la tête sur le côté gauche puis tourner légèrement à droite
 - c. Lever son oreille avec la main gauche
 - d. Insérer l'otoscope lentement avec la main droite en le tenant comme un stylo et en s'appuyant sur la tempe avec le petit doigt.
 - e. Observer le tympan et le triangle lumineux dans le cadran antéro-inférieur
3. *Surdité* : en masquant l'oreille opposée, on chuchote dans l'oreille du patient et celui-ci doit répéter.
4. *Test de Rinne* : diapason 512Hz sur le processus mastoïde jusqu'à ce qu'il n'entende plus puis devant l'oreille : le patient doit entendre à nouveau le son.
Test de Webber : diapason placé sur le crâne médialement : le son ne doit pas être latéralisé.

TECHNIQUES DE SOINS

PANSEMENTS

Matériel

1 Set de pansement	Sterilium
1 Mepore adapté à la taille de la plaie	Masque et gants
Chlorexydine	Compresse

Procédure

1. Port du masque, désinfection des mains
2. Ouverture du set de pansement
3. Etendre le champ stérile (visualiser une bordure septique et le centre aseptique), déposer la barquette dessus
4. Mettre de la Chlorhexidine sur la moitié des ouates
5. Déballe le matériel sur le champ : ciseau, scalpel, dégrafeur et compresse
6. Désinfection des mains, gants
7. Retirer le pansement existant après observation de (souillé ? suinte ? pus ? sang). Regarder l'intérieur du pansement
8. Retrait des gants avec le pansement dans la main
9. Désinfection des mains
10. Désinfecter la plaie depuis le plus stérile (plaie) jusqu'à l'extérieur
11. Retirer agrafes ou fils
12. Déposer une compresse pliée en deux sur la plaie
13. Recouvrir avec le Mepore
14. Désinfection des mains

INJECTIONS

5 B : Bonne personne, Bon médicament, Bonne dose, Bon endroit, Bon moment

Procédure de préparation du matériel

1. Désinfection main
2. Désinfection de la tablette
3. Vérification date de péremption, dosage, bon médicament
4. Faire descendre le liquide dans l'ampoule (tapoter, faire tourner)
5. Ouvrir la fiole en utilisant une compresse et en appuyant avec le pouce du côté du point blanc (sur la fiole)
6. Ouvrir la seringue et l'aiguille 19G : les assembler
7. Prendre liquide dans la fiole (technique avec la fiole entre les deux derniers doigts de la main droite)
8. Purger la seringue d'air et ajuster à la dose désirée
RAPPEL : le liquide dans l'aiguille n'est pas compté car il en restera la fin la même quantité dans l'aiguille
9. Adapter l'aiguille nécessaire à la technique de soin

Injection sous-cutanée

Zones : bras sous deltoïde, omoplate, péri-ombilic, cuisse antérieurement

1. Désinfection + gants
2. Désinfecter le point d'injection
3. Piquer en tenant comme un tournevis (~~style~~) après avoir pincé (45° chez personne normale, <90° si grasse ++)
4. Avant d'injecter, vérifier que l'on n'est pas en intraveineux en tirant légèrement la seringue : rien ne doit venir.

Injection intra-musculaire

Zones : Vaste latéral, deltoïde (éviter le fessier ant. et la zone sciatique)

1. Aiguille plus longue (4cm, 21G)
2. Désinfection + gants
3. Désinfecter le point d'injection
4. Piquer à 90° en tenant la seringue comme un stylo et en étirant la peau
5. Avant d'injecter, vérifier que l'on n'est pas en intraveineux en tirant légèrement la seringue : rien ne doit venir.

Injection épidermique (pas à l'ECOS)

Injection en parallèle à la peau avec une légère cathérisation. Maximum 1-2 ml

DOSSIER PATIENT

RAPPORT

Le rapport par oral (typiquement au chef de clinique ou lors de la transmission) se doit d'être succinct et structuré afin que l'écoute soit aisée. Le rapport doit être adapté selon l'auditeur : le chef de clinique sera intéressé par les détails concernant le patient tandis que la salle de colloque se contentera d'informations pertinentes et en relation avec le problème actuel.

La systématique est cependant toujours la même et suit le schéma suivant :

- | | |
|---|---|
| 1. Identité | <i>Patiente de (année de naissance) ...</i> |
| 2. Facteurs de risques et habitudes | <i>éthylotabagique à 50 UPA, vivant seul à domicile,</i> |
| 3. Antécédents | <i>connu pour (ATCD pertinent) en (année), ...</i> |
| 4. Problème actuel | <i>qui est hospitalisé pour (plainte, motif d'hospitalisation).</i> |
| 5. Anamnèse actuelle | <i>A l'entrée, la patiente présente (symptômes pertinents).</i> |
| 6. Status | <i>Au status, la patiente est hémodynamiquement stable, afebrile, orthopnéique avec (signes pertinents).</i> |
| 7. Examen paraclinique (labo, imagerie) | <i>Le laboratoire montre une leucocytose et une CRP à (valeur) et la radio du thorax révèle (signe + localisation).</i> |
| 8. Diagnostique | <i>Dans ce contexte, le diagnostique de (...) est retenu...</i> |
| 9. Traitements et investigations en cours | <i>pour lequel la patiente est mise sous (traitements et attitudes).</i> |

LETTRE DE SORTIE

La lettre de sortie est un rapport écrit qui atteste de l'hospitalisation du patient et des interventions et traitements qu'il a reçus. C'est un résumé qui sera particulièrement utile pour le médecin traitant ou pour retracer l'histoire du patient lors d'une prochaine hospitalisation. A nouveau, il est nécessaire d'être bref et de relever les points pertinents.

Certains détails sont spécifiques à chaque service, mais globalement, la structure est la suivante :

- | | |
|--|---|
| 1. Diagnostic primaire | (liste) |
| 2. Diagnostics secondaires | (liste) |
| 3. Interventions réalisées | (liste) |
| 4. Identité et habitudes | <i>Patient de (année de naissance) éthylo-tabagique</i> |
| Antécédents | <i>connu pour (ATCD pertinent) en (année), ...</i> |
| Problème actuel | <i>qui est hospitalisé pour (plainte, motif d'hospitalisation).</i> |
| 5. Anamnèse d'entrée | <i>A l'entrée, la patiente présente (symptômes pertinents).</i> |
| 6. Status d'entrée | <i>Au status, la patiente est (signes pertinents).</i> |
| 7. Examen paraclinique (labo, imagerie) | <i>Le laboratoire montre un syndrome inflammatoire et la radio du thorax révèle (signe + localisation).</i> |
| 8. Prise en charge et évolution par problème | <i>(Pour chaque problème) En raison de ..., le diagnostic de (...) est retenu... Dans ce contexte, un traitement par... est mis en place et la patiente évolue favorablement.</i> |
| 9. Evolution globale | <i>La patiente évolue favorablement et...</i> |
| Suite | <i>regagne son domicile le (date) avec les paramètres suivants : ...</i> |
| | <i>Une consultation chez le pneumologue est prévue (date)</i> |